内視鏡室で関わった高度凝固能異常を伴う消化管出血の一症例

◎脇坂 典子[1)]、飯田 智奈都[1)]、堀 雪子[1)]、山内 和美[1)]
公立羽咋病院[1)]

【はじめに】内視鏡業務に2013年より携わり、多職種で連携・協力し、安全かつ質の高い検査・治療の提供を心がけている。今回、高度凝固能異常を伴う消化管出血の一症例を経験した。本症例を通じ、検査専門職として事前検査や結果を把握すること、スタッフ間における情報共有の重要性を再認識したため報告する。

【症例】83才女性、要介護5、ADL全介助（施設入所）。＜既往歴＞パーキンソン症候群、慢性硬膜下血腫術後、胃瘻造設後、PT-INR過延長の既往（vit K欠乏疑い）。＜現病歴＞X月X日、前日からの大量下血、血圧低下にて救急搬送。10日前より発熱嘔吐、炎症反応高値あり絶食の上抗生剤投与。抗血栓薬・抗凝固薬内服なし。＜来院後の経過＞来院時BP62/39、暗赤色便多量。ドパミン開始。緊急内視鏡依頼あるも、内視鏡医より輸血しバイタル安定後に施行する旨と胃瘻チューブからの血液吸引有無確認の指示あり救急室にて直接救急医に報告。その際、採血提出あり検査室へ搬送、担当技師へ患者情報共有。採血結果Hb 8.1 g/dl（10日前：Hb 14 g/dl）、PT-INR 26.43、APTT 106.5秒と貧血および高度凝固能異常ありパニック値報告がされ、過去にも同様の凝固異常がありvit K欠乏疑いにてvitK2製剤が投与された。患者血液型はRBC製剤院内在庫がある血液型であり、即交差適合試験が進められ輸血開始後に上部内視鏡施行。十二指腸潰瘍あり潰瘍底の露出血管から活動性出血を認め止血処置が行われた。処置後入院しRBC製剤計4単位輸血。翌日採血Hb 12.0g/dl、PT-INR 1.22、APTT 30.8秒と改善。

【考察】本症例は抗血栓薬や抗凝固薬の内服はなく、vitK2投与で凝固能が改善したことから絶食と抗生剤投与によるvit K欠乏が示唆された。今回、凝固・血液型採血が事前にされ、その搬送に直接関わり検査担当技師と患者情報共有、内視鏡スタッフとパニック値や輸血に向けた進捗状況共有、救急看護師と検査室・内視鏡室双方の状況を共有することで安全に緊急内視鏡に望むことができた。

【結語】検査技師は検査科と内視鏡室双方の状況を把握できる存在である。事前検査や結果の把握に努め、なされていない場合等は積極的に行動し情報共有に努めたい。

連絡先：0767-22-1220（内線1360）